Act ratio による頸動脈狭窄の評価

◎佐藤 菜月[1)]、佐野 史江[1)]、楠山 美保[1)]、鈴木 崇浩[1)]、西野 諒[1)]、中西 加奈[1)]、尾崎 雅[1)]
地方独立行政法人 静岡市立静岡病院[1)]

【目的】収縮期加速時間比（Act ratio）を用いた評価が「頸動脈病変の標準的評価法追補版 2025」（日本超音波医学会）において提唱されたため、当検査室において導入可能か検討する。

【対象】2025 年 10 月 7 日から 31 日までに頸動脈超音波検査を施行した 99 名（男性 58 名、女性 41 名）、平均年齢 72±14 歳、検査件数 197 件（左右各 1 件としてカウント）。
Area 法による測定困難例は対象外とした。使用装置 : Aplio i800 および i700（Canon 製）。

【方法】未治療血管を対象に Area 法による狭窄の有無を正診とし、Act ratio による狭窄判定について感度および特異度を算出した。

【結果】検討の結果、感度 52%、特異度 72%であった。感度が低値のため再教育を実施し、測定手技の標準化を行った。追加検討として 2025 年 11 月 17 日から 12 月 11 日までの 92 名（男性 67 名、女性 25 名）、平均年齢 75±11 歳、検査件数 184 件を対象とした結果、感度 59%、特異度 81%となった。

【考察】追加検討により感度、特異度がいずれも改善し、測定手技の標準化が精度向上に不可欠であることが示された。経験の浅い技師は描出不良が Act ratio 測定に影響した症例が認められ、個人の技術向上が重要と考えられた。また、頸動脈の走行や分岐には個人差があり、解剖学的要因により描出困難となる症例も少なくない。このような場合には、他のモダリティによる狭窄評価も検討する必要がある。さらに、Area 法は NASCET 法と比較して狭窄を大きく評価する傾向があり、感度低値の一因と考えられた。測定手技の準拠により感度の上昇を認めたが、検査室で導入するためには低い結果となった。

【結語】Act ratio はガイドラインに準拠した測定が不可欠である。一方、導入のためには Area 法に基づく適切なカットオフ値の検討を要する。

連絡先　054-253-3125